

R/R LBCL

Estratificación de las pacientes por tiempo hasta el fracaso

Biopsia recomendada

2L

Refractario primario o R<12 meses

R>12 meses

Candidato a CAR-T

Sin intención de proceder a CAR-T

Axi-cel [I,A] o liso-cel [I,A]

GLOFIT- GemOX [I,A]
Tafasitamab-LEN [II,C] en
pacientes no refractarios
POLA-B-R[^] [I,B]

Candidato a trasplante

Sin intención de proceder
a trasplante

Inmunohistoquímica⁺ seguida de
HDT/ASCT si CR/PR [I,A]

GLOFIT- GemOX [I,A]
Tafasitamab-LEN [II,C] en
pacientes no refractarios
POLA-B-R[^] [I,B]

La decisión está influenciada por los tratamientos previos, el estado de la enfermedad y el estado general del paciente

3+L

Biopsia altamente recomendada

CAR-T [III,A]: axi-cel, liso-cel [III,A], anticuerpos
bienespecíficos [III,B]: epcoritamab, glofitamab,
odronextamab^{*} [III,B], tafasitamab-LEN [III,C],
POLA-B-R [III,B], loncastuximab tesirine^{*} [III,C]

En etapa limitada: IS-RT

Para todas las situaciones, evaluar la disponibilidad de ensayos clínicos.

^{*}No financiado en España. [†]Inmunoterapia de 2L antes de HDT/ASCT: R-DHAX (P o C), R-ICE, R-GDP, R-ESHAP → en caso de CMR, proceder con HDT/ASCT [I, A]. [^]No utilizar bendamustina si hay posibilidad de futuro CAR-T.

2L: segunda línea; **3+L:** tercera línea y sucesivas; **ASCT:** trasplante autólogo de células madre; **CAR-T:** CMR: respuesta metabólica completa; **CR:** respuesta completa; **HDT:** terapia de alta dosis (por sus siglas en inglés *high-dose therapy*); **IS-RT:** radioterapia en zonas afectadas (por sus siglas en inglés *involved site radiotherapy*); **LBCL:** linfoma de células B grandes; **Pola-B-R:** polatuzumab vedotin–bendamustina–rituximab; **PR:** respuesta parcial; **R-DHAX (P o C):** rituximab–dexametasona–citarabina–oxaliplatino (cisplatino o carboplatino); **R-ESHAP:** rituximab–etopósido, cisplatino– metilprednisolona; **R-GDP:** rituximab–gemcitabina–dexametasona–cisplatino; **R-GemOx:** rituximab–gemcitabina–oxaliplatino; **R-ICE:** rituximab–ifosfamida–carboplatino–etopósido.